

PHIẾU KẾT QUẢ SÀNG LỌC BỆNH DI TRUYỀN GEN LẶN**THÔNG TIN KHÁCH HÀNG**

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMT/CCCD:

Số điện thoại:

Giới tính:

Địa chỉ:

THÔNG TIN MẪU

Gói xét nghiệm:

Barcode:

Ngày thu mẫu:

Bác sĩ tư vấn:

Mã đại lý:

Ngày nhận mẫu:

Nơi gửi mẫu:

Loại mẫu:

Máu ngoại vi

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Bệnh di truyền	Gen xét nghiệm	Vị trí NST	Kết quả
Alpha-Thalassemia	HBA1 & HBA2	16p13.3	
Beta-Thalassemia	HBB	11p15.4	
Thiếu men G6PD	G6PD	Xq28	
Phenylketon niệu	PAH	12q23.2	
Rối loạn chuyển hoá galactose	GALT	9p13.3	
Bệnh vàng da ứ mật do thiếu hụt citrin	SLC25A13	1q21.3	
Rối loạn phát triển giới tính nam do thiếu 5 α -reductase type 2	SRD5A2	2q23.1	
Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ Glycogen loại 2)	GAA	17q25.3	
Bệnh Wilson (rối loạn chuyển hoá đồng)	ATP7B	13q14.3	
Bệnh xơ nang	CFTR	7q31.2	
Bệnh Fabry (Rối loạn tích trữ lipid thể tiêu hợp)	GLA	Xq22.1	
Thiếu hụt đa enzyme Acyl-CoA dehydrogenase	ETFDH	4q32.1	
Bệnh thận đa nang	PKHD1	6p12.3	
Tăng sản thượng thận bẩm sinh (Do thiếu men 21-hydroxylase)	CYP21A2	6p21.33	
Cường insulin bẩm sinh	ABCC8	11p15.1	
Teo cơ tủy sống (SMA)	SMN1	5q13.2	
Bệnh Gaucher (Thiếu hụt men glucocerebrosidase)	GBA	1q22	
Bệnh máu khó đông Hemophilia A	F8	Xq28	
Thiếu hụt hormone TSH đơn độc (Suy giáp bẩm sinh trung ương)	TSHB	1p13.2	
Tăng homocysteine niệu (Rối loạn chuyển hóa axi amin chứa lưu huỳnh)	CBS	21q22.3	

KẾT LUẬN:

LƯU Ý:

1. Xét nghiệm được thực hiện bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS- Next generation sequencing)
2. Các đột biến được khảo sát bao gồm: đột biến điểm, thêm hoặc mất đoạn nhỏ (trong khoảng 20 bp) trong vùng mã hoá và vùng lân cận intron (-20/+10 nucleotide từ exon) của các gen khảo sát.
3. Đối với gen HBA, các đột biến được phát hiện bao gồm: mất đoạn --SEA, --FIL, --THAI, - $\alpha^{3.7}$, - $\alpha^{4.2}$
4. Đối với gen HBB, đột biến được khảo sát bao gồm đột biến điểm trên vùng mã hoá và 4 đột biến điểm vùng intron phổ biến quần thể người Việt Nam: -IVSI-1(G>T), IVSI-1(G>A), IVSI-5(G>C), -IVSII-654(C>T)
5. Kỹ thuật này không thể xác định một số đột biến hiếm gặp như đột biến lặp đoạn hay xóa đoạn lớn, chuyển đoạn cân bằng, đảo đoạn, đa bội, nhiễm sắc thể cùng nguồn gốc từ bố hoặc mẹ (uniparental disomy) và những thay đổi các gốc methyl hóa.
6. Những biến thể xếp vào đột biến "gây bệnh" hoặc đột biến "có nguy cơ gây bệnh" sẽ được nêu ra trong báo cáo này theo hướng dẫn của Hiệp hội Di truyền Y học Hoa Kỳ (ACMG).
7. Việc phân tích phát hiện đột biến gen có thể sẽ không bao phủ được toàn bộ các đột biến gây bệnh ở những gen đã được phân tích.
8. Tất cả các thông tin này cần được tư vấn bởi các chuyên gia tư vấn di truyền.
9. Xét nghiệm được thực hiện bởi PXN bên ngoài.

KIỂM SOÁT KẾT QUẢ

Ngày tháng năm 20

GIÁM ĐỐC

CTCP GENETRUST VIỆT NAM
MST: 0111559308

Genetrust

— A trusted partner in Genomics —